جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عبير علي محمود خليل
المحافظة : المنوفيه **الحي / المدينة :** اشمون **العنوان :** كفر قورص
رقم البطاقة : 27309260100362 **رقم التليفون :** 01155480223 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 26-09-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: عبير علي محمود خليل
National ID: 27309260100362

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبير
على محمود خليل
كفر قورص
مركز اشمون - المنوفية

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢

KL4577961

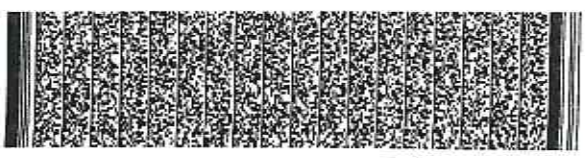
-٧٢٨-١١٢٠٦٩



٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢ ٢٠٢٤/٠٢

بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
خالد سعد خالد على
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٢/٢٦



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

اسم المريض بالإنجليزية: Abeer Ali Mahmoud	كود المريض: 98939
تاريخ التقرير: 2026/09/01 10:41:48 AM	السن: ٥٢ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52y/o lady with negative family history complaining of left breast lump of few months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular pattren.
- No other solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ three speculated irregular high density mass lesions with surrounding distortion. No suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- 1-2 o'clock three irregular spiculated heterogenous hypoechoic suspicious solid mass lesions seen as follows:
- Index lesion: posterior third, 7 cm from nipple, 7.5 mm deep to the skin measuring 27 x 25 mm.
- Mass A: anterior to the index by 3 mm, 6.5 mm deep to the skin, 5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- Mass B: anterior to mass A by 5 mm, 19 mm from the index, 10 mm deep to the skin, 4.5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- More than three level 1 pathological axillary LNs are noted, largest measured 8 x 9 mm with 4.5 mm cortical thickness. No pathological infra or supraclavicular lymph nodes.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): UOQ multifocal suspicious process with pathological axillary level 1 lymph nodes, for US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

PATHOLOGY REPORT

Code:	31626521350 -(P 26618-26)			Patient Name:	عبير على محمود
Age:	53 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	15/08/2026
Branch:	Ashmoon			Date Report Issued:	21/08/2026
Referred By Prof:	حمدى عبد الهادى حسن			Unit Consultant:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of left UOQ breast mass.
SPECIMEN: Left breast mass, Tru cut needle biopsy.

GROSS PICTURE: Core biopsy specimen, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed cores of breast tissue infiltrated by a malignant tumor. The tumor was composed of nests, cords and trabeculae with few tubules of malignant ductal epithelial cells showing moderate grade of cellular anaplasia. The stroma was desmoplastic with low T.I.L.s. No significant DCIS. No identified lymphovascular emboli or perineural invasion.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, Tru Cut Needle Biopsy Specimen:

- **Invasive Duct Carcinoma, *NST, Grade II.***

**1 enclosed slide.*

M. Tharwat

Dr. Mohamed Tharwat, M.D
Lecturer Of Pathology
Faculty of Medicine, Al Azhar University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :1-9-2026

جهه الاصدار :رئاسة الهيئة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) عبير على محمود بطاقة رقم 27309260100362

تليفون رقم: 01120687442

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :1-9-2026

الموظف المختص

مختار منصور

إفادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 2067100

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبير
على محمود خليل
كفر قورص
مركز اشمون - المنوفية

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢

KL4577961

-١١٢٠٦٩-٧٢٨

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢ ٢٠٢٤/٠٢
بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
خالد سعد خالد على
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٢/٢٦

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

اسم المريض بالإنجليزية: Abeer Ali Mahmoud	كود المريض: 98939
تاريخ التقرير: 2026/09/01 10:41:48 AM	السن: ٥٢ سنة ١١ شهر

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52y/o lady with negative family history complaining of left breast lump of few months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular pattren.
- No other solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ three speculated irregular high density mass lesions with surrounding distortion. No suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- 1-2 o'clock three irregular spiculated heterogenous hypoechoic suspicious solid mass lesions seen as follows:
- Index lesion: posterior third, 7 cm from nipple, 7.5 mm deep to the skin measuring 27 x 25 mm.
- Mass A: anterior to the index by 3 mm, 6.5 mm deep to the skin, 5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- Mass B: anterior to mass A by 5 mm, 19 mm from the index, 10 mm deep to the skin, 4.5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- More than three level 1 pathological axillary LNs are noted, largest measured 8 x 9 mm with 4.5 mm cortical thickness. No pathological infra or supraclavicular lymph nodes.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): UOQ multifocal suspicious process with pathological axillary level 1 lymph nodes, for US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Best regards,
Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

PATHOLOGY REPORT

Code:	31626521350 -(P 26618-26)			Patient Name:	عبير على محمود
Age:	53 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	15/08/2026
Branch:	Ashmoon			Date Report Issued:	21/08/2026
Referred By Prof:	حمدى عبد الهادى حسن			Unit Consultant:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of left UOQ breast mass.
SPECIMEN: Left breast mass, Tru cut needle biopsy.

GROSS PICTURE: Core biopsy specimen, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed cores of breast tissue infiltrated by a malignant tumor. The tumor was composed of nests, cords and trabeculae with few tubules of malignant ductal epithelial cells showing moderate grade of cellular anaplasia. The stroma was desmoplastic with low T.I.L.s. No significant DCIS. No identified lymphovascular emboli or perineural invasion.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, Tru Cut Needle Biopsy Specimen:

- **Invasive Duct Carcinoma, *NST, Grade II.***

**1* enclosed slide.*

M. Tharwat

Dr. Mohamed Tharwat, M.D
Lecturer Of Pathology
Faculty of Medicine, Al Azhar University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبير
على محمود خليل
كفر قورص
مركز اشمون - المنوفية

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢

KL4577961

-٧٢٨-١١٢٠٦٩

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢ ٢٠٢٤/٠٢
بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
خالد سعد خالد على
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٢/٢٦

اسم المريض بالإنجليزية: Abeer Ali Mahmoud	كود المريض: 98939
تاريخ التقرير: 2026/09/01 10:41:48 AM	السن: ٥٢ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52y/o lady with negative family history complaining of left breast lump of few months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular pattren.
- No other solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ three speculated irregular high density mass lesions with surrounding distortion. No suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- 1-2 o'clock three irregular spiculated heterogenous hypoechoic suspicious solid mass lesions seen as follows:
- Index lesion: posterior third, 7 cm from nipple, 7.5 mm deep to the skin measuring 27 x 25 mm.
- Mass A: anterior to the index by 3 mm, 6.5 mm deep to the skin, 5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- Mass B: anterior to mass A by 5 mm, 19 mm from the index, 10 mm deep to the skin, 4.5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- More than three level 1 pathological axillary LNs are noted, largest measured 8 x 9 mm with 4.5 mm cortical thickness. No pathological infra or supraclavicular lymph nodes.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): UOQ multifocal suspicious process with pathological axillary level 1 lymph nodes, for US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

PATHOLOGY REPORT

Code:	31626521350 -(P 26618-26)			Patient Name:	عبير على محمود
Age:	53 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	15/08/2026
Branch:	Ashmoon			Date Report Issued:	21/08/2026
Referred By Prof:	حمدى عبد الهادى حسن			Unit Consultant:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of left UOQ breast mass.
SPECIMEN: Left breast mass, Tru cut needle biopsy.

GROSS PICTURE: Core biopsy specimen, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed cores of breast tissue infiltrated by a malignant tumor. The tumor was composed of nests, cords and trabeculae with few tubules of malignant ductal epithelial cells showing moderate grade of cellular anaplasia. The stroma was desmoplastic with low T.I.L.s. No significant DCIS. No identified lymphovascular emboli or perineural invasion.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, Tru Cut Needle Biopsy Specimen:

- **Invasive Duct Carcinoma, *NST, Grade II.***

**1 enclosed slide.*

M. Tharwat

Dr. Mohamed Tharwat, M.D
Lecturer Of Pathology
Faculty of Medicine, Al Azhar University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :1-9-2026

جهه الاصدار :رئاسة الهيئة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) عبير على محمود بطاقة رقم 27309260100362

تليفون رقم: 01120687442

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :1-9-2026

الموظف المختص

مختار منصور

إفادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 2067100

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبير
على محمود خليل
كفر قورص
مركز اشمون - المنوفية

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢

KL4577961

-١١٢٠٦٩-٧٢٨

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢ ٢٠٢٤/٠٢
بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
خالد سعد خالد على
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٢/٢٦

اسم المريض بالإنجليزية: Abeer Ali Mahmoud	كود المريض: 98939
تاريخ التقرير: 2026/09/01 10:41:48 AM	السن: ٥٢ سنة ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52y/o lady with negative family history complaining of left breast lump of few months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular pattren.
- No other solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ three speculated irregular high density mass lesions with surrounding distortion. No suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- 1-2 o'clock three irregular spiculated heterogenous hypoechoic suspicious solid mass lesions seen as follows:
- Index lesion: posterior third, 7 cm from nipple, 7.5 mm deep to the skin measuring 27 x 25 mm.
- Mass A: anterior to the index by 3 mm, 6.5 mm deep to the skin, 5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- Mass B: anterior to mass A by 5 mm, 19 mm from the index, 10 mm deep to the skin, 4.5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- More than three level 1 pathological axillary LNs are noted, largest measured 8 x 9 mm with 4.5 mm cortical thickness. No pathological infra or supraclavicular lymph nodes.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): UOQ multifocal suspicious process with pathological axillary level 1 lymph nodes, for US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

PATHOLOGY REPORT

Code:	31626521350 -(P 26618-26)			Patient Name:	عبير على محمود
Age:	53 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	15/08/2026
Branch:	Ashmoon			Date Report Issued:	21/08/2026
Referred By Prof:	حمدى عبد الهادى حسن			Unit Consultant:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of left UOQ breast mass.
SPECIMEN: Left breast mass, Tru cut needle biopsy.

GROSS PICTURE: Core biopsy specimen, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed cores of breast tissue infiltrated by a malignant tumor. The tumor was composed of nests, cords and trabeculae with few tubules of malignant ductal epithelial cells showing moderate grade of cellular anaplasia. The stroma was desmoplastic with low T.I.L.s. No significant DCIS. No identified lymphovascular emboli or perineural invasion.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, Tru Cut Needle Biopsy Specimen:

- **Invasive Duct Carcinoma, *NST, Grade II.***

**1 enclosed slide.*

M. Tharwat

Dr. Mohamed Tharwat, M.D
Lecturer Of Pathology
Faculty of Medicine, Al Azhar University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبير
على محمود خليل
كفر قورص
مركز اشمون - المنوفية

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢

KL4577961

-٧٢٨-١١٢٠٦٩

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢ ٢٠٢٤/٠٢
بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
خالد سعد خالد على
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٢/٢٦

اسم المريض بالإنجليزية: Abeer Ali Mahmoud	كود المريض: 98939
تاريخ التقرير: 2026/09/01 10:41:48 AM	السن: ٥٢ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52y/o lady with negative family history complaining of left breast lump of few months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular pattren.
- No other solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ three speculated irregular high density mass lesions with surrounding distortion. No suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- 1-2 o'clock three irregular spiculated heterogenous hypoechoic suspicious solid mass lesions seen as follows:
- Index lesion: posterior third, 7 cm from nipple, 7.5 mm deep to the skin measuring 27 x 25 mm.
- Mass A: anterior to the index by 3 mm, 6.5 mm deep to the skin, 5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- Mass B: anterior to mass A by 5 mm, 19 mm from the index, 10 mm deep to the skin, 4.5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- More than three level 1 pathological axillary LNs are noted, largest measured 8 x 9 mm with 4.5 mm cortical thickness. No pathological infra or supraclavicular lymph nodes.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): UOQ multifocal suspicious process with pathological axillary level 1 lymph nodes, for US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

PATHOLOGY REPORT

Code:	31626521350 -(P 26618-26)			Patient Name:	عبير على محمود
Age:	53 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	15/08/2026
Branch:	Ashmoon			Date Report Issued:	21/08/2026
Referred By Prof:	حمدى عبد الهادى حسن			Unit Consultant:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of left UOQ breast mass.
SPECIMEN: Left breast mass, Tru cut needle biopsy.

GROSS PICTURE: Core biopsy specimen, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed cores of breast tissue infiltrated by a malignant tumor. The tumor was composed of nests, cords and trabeculae with few tubules of malignant ductal epithelial cells showing moderate grade of cellular anaplasia. The stroma was desmoplastic with low T.I.L.s. No significant DCIS. No identified lymphovascular emboli or perineural invasion.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, Tru Cut Needle Biopsy Specimen:

- **Invasive Duct Carcinoma, *NST, Grade II.***

**1 enclosed slide.*

M. Tharwat

Dr. Mohamed Tharwat, M.D
Lecturer Of Pathology
Faculty of Medicine, Al Azhar University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :1-9-2026

جهه الاصدار :رئاسة الهيئة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) عبير على محمود بطاقة رقم 27309260100362

تليفون رقم: 01120687442

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :1-9-2026

الموظف المختص

مختار منصور

إفادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 2067100

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبير
على محمود خليل
كفر قورص
مركز اشمون - المنوفية

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢

KL4577961

-١١٢٠٦٩-٧٢٨

٢٧٣٠٩٢٦٠١٠٠٣٦٢ ٢٠٢٤/٠٢
بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
خالد سعد خالد على
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٢/٢٦

اسم المريض بالإنجليزية: Abeer Ali Mahmoud	كود المريض: 98939
تاريخ التقرير: 2026/09/01 10:41:48 AM	السن: ٥٢ سنة ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52y/o lady with negative family history complaining of left breast lump of few months duration.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular pattren.
- No other solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR density b).
- UOQ three speculated irregular high density mass lesions with surrounding distortion. No suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- 1-2 o'clock three irregular spiculated heterogenous hypoechoic suspicious solid mass lesions seen as follows:
- Index lesion: posterior third, 7 cm from nipple, 7.5 mm deep to the skin measuring 27 x 25 mm.
- Mass A: anterior to the index by 3 mm, 6.5 mm deep to the skin, 5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- Mass B: anterior to mass A by 5 mm, 19 mm from the index, 10 mm deep to the skin, 4.5 cm from nipple, measuring 11 x 6 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- More than three level 1 pathological axillary LNs are noted, largest measured 8 x 9 mm with 4.5 mm cortical thickness. No pathological infra or supraclavicular lymph nodes.

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 5): UOQ multifocal suspicious process with pathological axillary level 1 lymph nodes, for US-Guided Tru-cut biopsy and histopathological correlation.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

المختبر
al mokhtabar
moamena kamel lab
معامل مؤمنة كامل

PATHOLOGY REPORT

Code:	31626521350 -(P 26618-26)			Patient Name:	عبير على محمود
Age:	53 Y	Sex:	Female	Specimen Received Date:	15/08/2026
Branch:	Ashmoon			Date Report Issued:	21/08/2026
Referred By Prof:	حمدى عبد الهادى حسن			Unit Consultant:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of left UOQ breast mass.
SPECIMEN: Left breast mass, Tru cut needle biopsy.

GROSS PICTURE: Core biopsy specimen, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed cores of breast tissue infiltrated by a malignant tumor. The tumor was composed of nests, cords and trabeculae with few tubules of malignant ductal epithelial cells showing moderate grade of cellular anaplasia. The stroma was desmoplastic with low T.I.L.s. No significant DCIS. No identified lymphovascular emboli or perineural invasion.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, Tru Cut Needle Biopsy Specimen:

- **Invasive Duct Carcinoma, *NST, Grade II.***

**1 enclosed slide.*

M. Tharwat

Dr. Mohamed Tharwat, M.D
Lecturer Of Pathology
Faculty of Medicine, Al Azhar University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.